

CAPÍTULO 9.1

Anemia: Generalidades

PERFIL EUNACOM 1.07.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Anemias: Generalidades y Clasificación

Definición

TABLA 9.1.1: SEXO VS HEMOGLOBINA (HB)	
SEXO	HEMOGLOBINA (HB)
Hombre	< 13 g/dL
Mujer	< 12 g/dL

Hematocrito ≈ 3 × Hb (ej: Hto 30% → Hb ~10 g/dL)

Clínica — Síndrome Anémico

- Palidez de piel, mucosas y conjuntivas
- Taquicardia + soplo sistólico eyectivo (funcional)
- Astenia, adinamia
- Disnea (en casos graves)

Clasificación por VCM (Volumen Corpuscular Medio)

TABLA 9.1.2: VCM VS TIPO		
VCM	TIPO	CAUSAS PRINCIPALES
< 80 fL	Microcítica	Ferropenia, talasemia, anemia sideroblástica
80–100 fL	Normocítica	Enf. crónica, hemólisis, insuficiencia renal, aplasia
> 100 fL	Macrocítica	Déficit B12, déficit folatos, alcohol, hipotiroidismo , mielodisplasia

Índice Reticulocitario (IR)

- Fórmula: IR = (% reticulocitos × Hto) / 45 / tiempo de maduración
- **IR > 2% = Anemia regenerativa** → médula responde bien → causa: hemólisis o hemorragia aguda
- **IR < 2% = Anemia arregenerativa** → médula no responde → todas las demás causas

EUNACOM CRITERIOS

Hemorragia crónica → **arregenerativa** (genera ferropenia). Solo la hemorragia aguda es regenerativa.

Algoritmo Diagnóstico

- **Hemograma completo** → VCM + otras líneas (leucocitos, plaquetas) + frotis
- **Reticulocitos / índice reticulocitario** → ¿regenerativa o no?

- Exámenes según sospecha:
- - **Perfil de hierro** (ferritina, transferrina, TIBC, saturación)
- - Vitamina B12 y folatos
- - Biopsia de médula ósea (leucemia, mielodisplasia)
- - Electroforesis de proteínas (**hemoglobinopatías**)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

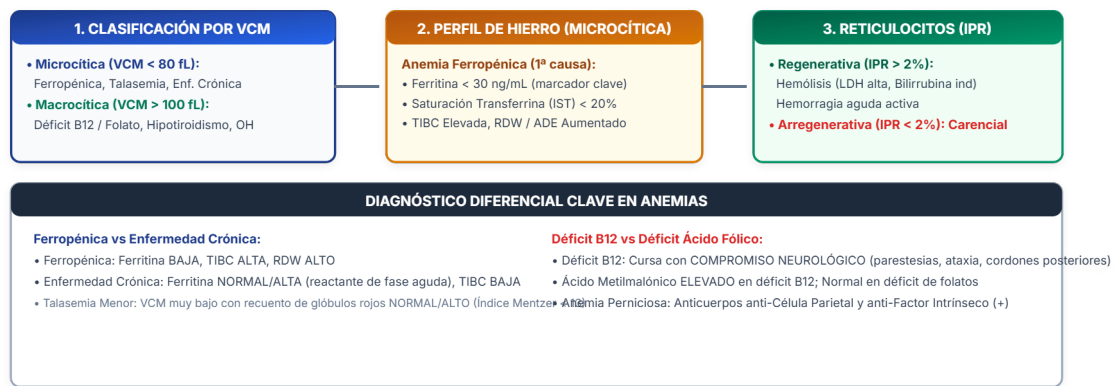
"Mujer de 35 años consulta por astenia progresiva, adinamia y cefalea. Al examen: palidez conjuntival y palmar, FC 98 lpm con soplo sistólico eyectivo I/VI multifocal. Hemograma: Hb 8.8 g/dL, Hematocrito 27%, VCM 74 fL, HCM 24 pg, Leucocitos y Plaquetas normales."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Síndrome Anémico Microcítico Hipocrómico: caracterizado por síntomas de hipoxemia tisular y compensación cardiovascular hiperdinámica. El paso inicial tras el hemograma con VCM bajo (< 80 fL) es solicitar Perfil de Hierro completo (Ferritina, Sideremia, TIBC, Capacidad de fijación y Saturación de Transferrina) e Índice de Producción Reticulocitaria (IPR).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El diagnóstico de anemia se hace con hemoglobina <13 g/dL en hombres y <12 g/dL en mujeres
- El hematocrito es aproximadamente tres veces la hemoglobina
- El VCM normal es entre 80 y 100 fL y permite clasificar la anemia en microcítica, normocítica o macrocítica
- La anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia microcítica
- La anemia por enfermedades crónicas es la causa más frecuente de anemia normocítica
- El déficit de B12 es la causa más frecuente de anemia macrocítica en Chile
- El índice reticulocitario >2 indica anemia regenerativa: hemólisis o hemorragia aguda
- El índice reticulocitario <2 indica anemia arregenerativa (todas las demás causas)
- Las hemorragias crónicas son arregenerativas porque tienden a la ferropenia
- Siempre revisar el frotis del hemograma: los esquistocitos indican anemia hemolítica

FIGURA 9.1: ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE ANEMIAS SEGÚN VCM E ÍNDICE RETICULOCITARIO**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANEMIA: GENERALIDADES)****PREGUNTA 1**

Paciente masculino de 45 años consulta por astenia progresiva. Se solicita hemograma que muestra hemoglobina de 10 g/dL, VCM de 72 fL y plaquetas de 480.000/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Anemia por enfermedades crónicas
- B)** Anemia ferropénica
- C)** Anemia por déficit de vitamina B12
- D)** Talasemia
- E)** Mielodisplasia

PREGUNTA 2

¿Cuál de las siguientes anemias se clasifica como regenerativa?

- A)** Anemia ferropénica
- B)** Anemia por enfermedades crónicas
- C)** Anemia hemolítica
- D)** Anemia por déficit de vitamina B12
- E)** Anemia por hemorragia crónica

PREGUNTA 3

Paciente con anemia y VCM de 110 fL. ¿Cuál de las siguientes causas es MENOS probable?

- A)** Déficit de vitamina B12
- B)** Consumo crónico de alcohol
- C)** Talasemia
- D)** Hipotiroidismo
- E)** Mielodisplasia

RESUMEN: ANEMIA: GENERALIDADES

Esta clase introduce las generalidades del tema de anemias en hematología. Se describe el síndrome anémico, caracterizado por palidez de piel, mucosas y conjuntivas, taquicardia, soplo sistólico eyectivo funcional, astenia, adinamia y disnea en casos graves. El diagnóstico de anemia se establece con hemoglobina menor a 13 g/dL en hombres y menor a 12 g/dL en mujeres. El hematocrito es aproximadamente tres veces la hemoglobina. Las causas son múltiples: ferropénica, enfermedades crónicas, hemólisis, déficit de vitamina B12 y folatos, cánceres hematológicos y no hematológicos, enfermedades genéticas, entre otras. Para el estudio de la anemia, se evalúa el hemograma completo con frotis, el VCM (normal 80-100 fL), el índice reticulocitario, el perfil de hierro, niveles de vitamina B12 y folato, biopsia de médula ósea y electroforesis de proteínas según sospecha clínica. Las anemias se clasifican según el VCM en microcíticas (VCM <80: ferropénica, talasemia, sideroblástica), normocíticas (VCM 80-100: enfermedad crónica, hemolíticas, genéticas) y macrocíticas (VCM >100: déficit de B12 y folatos, alcohol crónico, hipotiroidismo, mielodisplasia). El índice reticulocitario mayor a 2 indica anemia regenerativa (hemólisis o hemorragia aguda), mientras que menor a 2 indica anemia arregenerativa.